전신질환 관련
치과치료 가이드라인

안전한 치과치료를 위한 전신질환별 주의사항과 관리 지침

KDA 경기도치과의사회 GYEONGGI DENTAL ASSOCIATION

GAMEX 2026

심혈관질환

고혈압, 협심증, 심근경색증, 스텐트 삽입환자, 부정맥, 심장판막 질환자, 울혈성 심부전, 류마티스성 심장질환 등

■ 공통 원칙
- -수축기 180 / 이완기 110 이상 의 심한 고혈압 → 치과치료 연기, 순환기내과 의뢰
- -통증 조절(무통 마취, 전투약고려), 긴장 완화
- -오후보다는 오전에 진료
- -1:10만 에피네프린 포함 리도카인 앰플 가능한 적게(2 앰플 이하 권장), 마취 시 흡인 필요
- -항혈소판제/항응고제 임의 중단 절대 금지 –중단 필요할 경우 협진의뢰서 반드시 필요!!

■ 심근경색증, 부정맥
- -6개월 이내 스텐트 삽입 혹은 1년 이내 심근경색증 병력 환자 진료시-협진의뢰서 반드시 필요!!
- -삽입형 제세동기 or 심박조율기(pacemaker) - 전기소작기(보비) 임의 사용 금지
- -보비 사용이 꼭 필요하면 심박조율기 mode 조정 의뢰

■ 울혈성 심부전
- -대부분 치료중인 심부전 환자는 치료 가능 but, 놉는 자세가 어렵다면 협진의뢰서 작성 후 치료 연기

■ 감염성 심내막염 : 위험성 있는 환자 (판막 수술, 이전 심내막염 기왕력 등)
- -관혈적 치료(출혈이 예상되는 구강내 시술) 전 예방적 항생제 반드시 필요!!
 또한 근관치료(manipulation of periapical region) 시에도 예방적 항생제 필요!!
- -시술 30-60 분 전
 아목시실린 2g (경구) - ex.) 오구멘틴 625mg (아목시실린 500mg, 클라불란산 125mg) 4T
 or 아지스로마이신, 클래리스로마이신 500mg (경구) - 페니실린 알러지가 있는 경우

간질환

시술 전 B·C형 간염 여부 확인 필요
(C형 간염·AIDS는 오라퀵으로 15분 내 검사 가능)
감염 환자로부터 찔림 사고 발생 시 감염내과로 내원.

■ 간경화
- -혈소판 감소 및 응고 장애로 인한 출혈 경향에 대해 주의 요함
- -가능하다면 일반혈액검사(CBC, PT coagulation time) 시행 후 치료
- -간대사 약물의 사용 주의되나 일반적 치과진료 후 처방 약제 대부분 문제없음
- -진통제 투약 시 간독성 존재하나 비교적 안전한 아세트아미노펜 4g/day 이하
 (간경화 등 간 질환자에서는 2g/day 이하)
- -NSAID 의 경우 오히려 출혈 뿐 아니라 신기능 저하 및 체액 저류 위험 증가

■ B형간염 — 찔림 사고시
- -의료진이 항체가 있는 경우 문제 없음
- -항체 없는 경우 HB면역글로블린 240IM 0.05ml/kg IM 1회 투여
- -추적: HBs Ag f/u (노출 3개월·6개월 후)
- -항체 없는 경우 B형 간염 예방 접종 실시

■ C형간염 — 찔림 사고시
- -역글로불린 효과 없음
- -추적검사
 · 노출 4~6주 : HCV RNA(PCR)
 · 노출 4~6개월 : anti HCV(항체)

폐질환

■ 천식
- -수술 전 긴장 완화
- -NSAID 과민 과거력 있는 경우 사용 금기
- -발작 시 inhaler 사용할 수 있도록 지참 권고
- -필요시 스테로이드 투여(투여 필요시 협진의뢰서 작성)

■ 만성 폐쇄성 폐질환
- -생체 징후 모니터링 (산소포화도 체크 필수)
- -오전보다는 오후 진료
- -앉은 상태에 가까운 자세로 진료
- -양측성 하악 전달마취 금기
- -필요할 시 산소공급 및 스테로이드 투여
 (투여 필요시 협진의뢰서 작성)

항암화학요법 · 방사선요법

*** 협진의뢰서 반드시 필요!!

■ 항암화학요법
- -항암화학요법 최소 1~2주전 치과 치료 완료
- -종료 3주 이후 발치 등 치과치료 가능
 (단, 호중구 절대수(ANC) 1천~1천500, 백혈구 2천, 혈소판 5만 이상시 발치 가능)
- -ANC, 백혈구 기준 이하시 예방적 항생제 투여

■ 방사선요법
- -방사선요법 최소 3주 전 치과치료 완료
- -두경부 영역 방사선요법 종료 6개월 이내 발치 등 필요시 상급병원 전원

내분비질환

■ 당뇨병
- -공복혈당 200 mg/dL 초과, 당화혈색소 8% 이상인 경우-협진의뢰서 반드시 필요!!
- -수술 전과 후 적극적인 혈당 조절 필요
- -저혈당 대비 : 치료 전 정상적인 식사와 투약 설명 / 사탕, 오렌지 주스 준비
- -치유 지연, 창상 감염 주의(항생제 처방 등)

■ 부신기능부전증
- -수술 시 수술 전후 스테로이드 추가 투여 고려 – 장시간의 수술의 경우 협진의뢰서 반드시 필요!!
- -but, 일반적 치과 치료시 큰 stress가 아니어서 추가 스테로이드 투여 거의 필요 없으며,
 평소 복용하던 스테로이드는 꼭 복용하도록 설명

■ 갑상선기능항진증
- -생체징후 모니터링, 에피네프린 포함 국소마취제 사용 시 주의
- -조절이 잘 안되고 있는 경우 치료 연기 -협진의뢰서 반드시 필요!!

■ 갑상선기능저하증
- -갑상선 약물 복용중이라면 일반적 치과치료에 따른 위험 낮음

신장질환

출혈 경향, 치유 지연, 창상 감염 주의

■ 혈액투석 or 복막투석 환자
- -경구 항생제는 오구멘틴 375mg 1T BID로 처방
- -진통제의 경우 NSAID 단기간 사용 가능하나, 잔여 신기능 보호를 위해 아세트아미노펜(AAP) 추천
- -투석 다음날 치과 치료 시행. 출혈 위험성 클 경우-미리 협진의뢰서 작성하여 heparin free 투석 요청

■ 만성 신장병환자 (투석하지 않는 환자)
- -진통제는 NSAID 대신 AAP로 투약!!, NSAID같은 신독성 약물의 사용 주의
- -항생제는 신기능에 맞추어 투약 및 용량감소
- -사구체여과율(eGFR)이 10 ml/min 이상
 → 항생제는 오구멘틴(amoxicillin/clavulanate) 375mg 1T BID로 처방
 (단, 10 이하인 경우 375mg 1T QD, 30 이상인 경우 625mg 1T BID
- -필요시 협진의뢰서

■ 신장이식환자
- -시술 당일 금식 필요하더라도 소량의 물과 함께 면역억제제 복용 지시, NSAID 대신 AAP로 투약
- -항생제는 신기능에 맞추어 투약 및 용량감소
- -출혈 등이 있어 감염의 위험성 있을 경우 예방적 항생제 고려, 필요시 협진의뢰서

약물관련 악골괴사증(MRONJ, BRONJ)

골흡수 억제를 억제하는 골다공증 치료제,
암전이 예방과 면역억제를 위한 혈관생성 억제제,표적치료제 등에 의해 발생

*** 협진의뢰서 반드시 필요!!

■ 골다공증으로 인한 투여
- -비스포스포네이트(~dronate) 계열
 주 1회(경구) / 월 1회·3개월 1회·6개월 1회(정주)투약하는 경우가 많음 — 복용 주기 먼저 문의
 "일주일에 한 번 먹는 약이나 몇 달에 한번 맞는 주사가 있는지"
- -monoclonal antibody 계열
 데노수맙(골다공증의 경우 프롤리아 6개월에 한번 피하주사)

■ 치과 관혈적(침습적) 시술시
- -MRONJ 발생 위험군으로 시술 전 휴약기 권고(술 전 약 3개월 정도)
 (단, 졸레드로네이트 주사제의 경우 : 6~12개월 중단 고려)
- -시술 후 약 6~8주간의 휴약기 권고
 (단, 데노수맙의 경우 휴약기가 최대 9개월 넘지 않도록 권장 - rebound fx. 등 발생 가능 이유)
- -칼슘, 비타민 D, 선택적 에스트로겐 수용체 조절제(SERM), Teriparatide로 변경 문의
- -투약 기간이 짧더라도 MRONJ 발생할 수 있어 관혈적(침습적) 시술시
 반드시 발생 가능성 고지 및 동의서 필요

임신

- -임신 2기(임신 4개월~6개월) 치료 추천
- -장시간 누운 자세 금지
- -방사선 촬영이 불가피하다면 적절한 방어
- -항생제는 아목시실린, 세파 1, 2세대(세팔렉신, 세파클러 등), 진통제는 NSAID 대신 AAP 처방 권장
- -수유할 때는 수유 직후에 투약(수유 간격 6시간 이상)

본 가이드라인은 임상적 참고를 위한 것으로, 개별 환자에 대한 확정적인 치료 지침은 아니오니,
실제 적용 시 반드시 환자의 상태를 면밀히 평가한 후 진행하시기 바랍니다.

presented by 유재식 제이탑치과의원 JTOP DENTAL CLINIC (전) 조선대학교 치과대학 구강악안면외과 교수 KDA 경기도치과의사회 GYEONGGI DENTAL ASSOCIATION